Advanced Search

ASKEP - CPPT (Chatarina Danik Wijayanti, , S.Farm., Apt)

## LIST REGISTRASI 16 OCT 2026

RAWAT INAP

Merak

No. RM Pasien

Nama Pasien

Cari Pasien  Reset

| No | Tgl Reg | No RM | Nama | Ruang | No. Reg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/10/16 | 00284571 | NGATIK | Merak | 020201202600010546002 |
| 2 | 2026/10/15 | 00008848 | ALFREEDA NIRWIRA KHARISMA | Merak | 020201202600010541001 |
| 3 | 2026/10/15 | 00331800 | SRI WAKHIDAH | Merak | 020201202600010530001 |
| 4 | 2026/10/14 | 00061527 | SRI SUMIYATI | Merak | 020201202600010492001 |
| 5 | 2026/10/14 | 00109480 | SUNARTI | Merak | 020201202600010503001 |
| 6 | 2026/10/14 | 00055650 | RAFID AGASTIA KUMARA | Merak | 020201202600010500002 |

## DATA PRIBADI PASIEN PER 16 OCT 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Registrasi | **02020120260001050300 1** | Jenis Kel./Gol.Darah | **Perempuan / TIDAK TAHU** |
| Tanggal Registrasi | **14-10-2026** | Sub Instalasi/Poli | **Merak** |
| No. RM / No. Ident | **00109480 / 3402125811630001** | Sub Divisi | **-** |
| Nama | **SUNARTI** | Kamar/No. Bed | **MERAK 314 / 14A** |
| Alamat | **JL JANTI KANOMAN RT.7, BANGUNTAPAN, BANGUNTAPAN** | Cara Bayar | **JKN Non PBI** |
| No. Telp. | **089634090927** | Alergi | **AMOXISILIN DAN AMPISILIN** |
| Tanggal Lahir | **18-11-1963 (62 th 10 bln 28 hr)** | Alergi Obat | |
| Agama | **ISLAM** | Nama DPJP | **dr. Raden Triyono Edhi Sulistiyanto Sp.PD.,FINASIM** |

## MENU

- **RESUME HISTORY (PROFIL RINGKAS MEDIS)**
- **BERKAS RM**
- **MATRIK HASIL LAB**
- **HISTORY HASIL LAB**
- **HISTORY HASIL RADIOLOGI**
- **HISTORY HASIL PATOLOGI**
- **HISTORY HASIL PEMERIKSAAN LAIN**
- VIEW ASSESMENT AWAL
- RPPT & CPPT
- INTEGRATED NOTES
- DOKUMEN EKSTERNAL
- PLANNING - ( P )
  - EDUKASI PASIEN
- TRANSFER PASIEN

## RESUME HISTORY (PROFIL RINGKAS MEDIS)

RAWAT JALAN RAWAT INAP GAWAT DARURAT PENUNJANG HOMECARE KONSULTASI ONLINE Semua Pelayanan

**1. 14-10-2026 20:45:04 (Merak) DPJP: dr. RADEN TRIYONO EDHI SULISTIYANTO Sp.PD.,FINASIM**

**ASESMEN AWAL**

**Assesment Awal**

**Tanggal Assesment**: 15-10-2026 07:36

**Riwayat Vaksinasi Covid-19**: **Ya**

**Keluhan Utama**: Keluhan utama : Muntah berulang, lemas -

**Riwayat Penyakit Sekarang**: Riwayat penyakit sekarang : Pasien datang dengan keluhan muntah berulang dan lemas yang semakin memberat. Keluhan mual +, muntah + muncul sejak 3 hari SMRS, muntah setiap kali makan dan minum, hari ini muntah >10x. Anak pasien menyampaikan hari sabtu malam (4 hari SMRS) pasien minum susu jahe yang di beli di pinggir jalan, lalu keesokan harinya mulai pusing + nggliyer muter, mual +, muntah +, lemas +, batuk + berdahak putih +, dan berkeringat gobyos setiap hari hingga sore ini. Nafsu makan pasien sangat berkurang karena mual, 2 hari ini hanya minum dan tidak mau makan. Keluhan sesak -, nyeri dada -, nyeri perut -, kelemahan anggota gerak -. Pasien sudah periksa ke UGD RPSAU tgl 11/10/2026, diinjeksi obat dan pulang. Sore ini pasien periksa ke Klinik Pratama Ramadhan dengan keluhan lemas, GDS: 294, dan tensi 90/60, disarankan untuk langsung ke UGD RSPAU. RPD: - HT on tx rutin - DM on tx rutin - Riw. Vertigo + - Post OP Phaco + IOL OS a.i Katarak Komplikata dgn dr. Sri Harto, Sp.M tgl 04/08/2026 - Jantung - RPO: Obat dari UGD RSPAU tgl 11/10/2026 - Becom C 1x1 - Betahistin 3x6 mg - Ibuprofen 2x400 mg Obat rutin Poli dr. Edhie, Sp.PD tgl 09/10/2026 - Amlodipin 1x10 mg - Clopidogrel 1x75 mg - Glimepirid 1x3mg - Metformin 1x500 mg *R.Alergi: Amoxicilin dan Ampisilin* Diagnosa - Diagnosa Utama : - VOMITUS PROFUS EC DALAM PELACAKAN - Diagnosa Sekunder 1 : - ANOREXIA GERIATRI - Diagnosa Sekunder 2 : - ISPA - Diagnosa Sekunder 3 : - HT ON TX RUTIN - Diagnosa Sekunder 4 : - DM ON TX RUTIN

**Riwayat Penyakit Dahulu**: ---

**Obat-obat yang sering digunakan**: ---

**Lama Perkiraan Dirawat**: 3 Hari

**Pemeriksaan Fisik**

**Tanda Vital**

**Tekanan Darah Sistole**: 125 mmHg

**Tekanan Darah Diastole**: 68 mmHg

**Frekuensi Nadi**: 80 x/menit

**Isi & Tegangan**: cukup

**Irama**: reguler

**Frekuensi Nafas**: 20 x/menit

**Suhu**: 36.5 °C

**Tipe & Irama:**: Keluhan utama : Muntah berulang, lemas -

**Spo2**: 98 %

**Nyeri**

**Status Nyeri**: TIDAK

**Kepala**: Tidak Ada Kelainan

**Leher**: Tidak Ada Kelainan

**Perut**

**Perut**: Tidak Ada Kelainan

**Limpa**: Tidak Ada Kelainan

**Extrimitas**

(http://instistream:3000)AKAN ()

- **Atas**: Tidak Ada Kelainan
- **Bawah**: Tidak Ada Kelainan

**Anogenitalia**

- **Bawah**: Tidak Ada Kelainan

**Temuan Fisik Lain**: Tidak Ada Kelainan

**Diagnosis**: -Vomitus Profuse ec dalam pelacakan - DM dengan Hiperglikemia - Riw. Hipertensi - Hiponatremia & Hipochlorida ringan

**Masalah**: [--

**Pemeriksaan Penunjang yang menunjang diagnosis**

- **Hasil Lab**: Laboratorium Patologi Klinik (14-10-2026 19:42:49) - Hemoglobin, Hasil: 11.6g/dL (11.7 - 15.5) - Trombosit, Hasil: 239000/mm³ (150000 - 440000) - Glukosa Darah Sewaktu, Hasil: 310mg/dL (< 200), Catatan: Secara pra analitik sampel baik, hasil sudah dilakukan pengulangan. - SGOT, Hasil: 39U/L (< 35) - SGPT, Hasil: 23U/L (< 34) - Ureum, Hasil: 57mg/dL (21 - 43) - Kreatinin, Hasil: 1.80mg/dL (0.6 - 1.1) - Natrium (Na), Hasil: 127.36mmol/L (135.0 - 147.0), Catatan: Secara pra analitik sampel baik, hasil sudah dilakukan pengulangan.
- **Hasil Radiologi**: Radiodiagnostik (14-10-2026 19:50:08) - Pulmo tak tampak kelainan - Besar Cor normal
- **Hasil Patologi Anatomi**: --
- **Hasil Penunjang Lain**: --

## PENGKAJIAN DAN ASUHAN GIZI

**Riwayat Pemeriksaan Gizi**

- **Ruang / Poli** : merak
- **Tanggal**: 2026-10-15
- **Jam**: 09:28
- **Utama (kali/hari)**: 3x
- **Selingan / Ngemil (kali/hari)**: 2x
- **Ada alergi terhadap makanan**: Tidak
- **Ada makanan pantangan**: Ya
- **Jika ya, sebutkan pantangan makanannya**: Makanan/minuman tinggi glukosa, natrium
- **Kebiasaan makan berkaitan dengan penyakit**: Nafsu makan menurun, recall asupan <80%
- **Antropometri**: BB : 60 kg TB : 156 cm IMT : 24,65 kg/m2 Status Gizi : Normal
- **Biokimia**: Laboratorium Patologi Klinik (15-10-2026 08:19:14) - Glukosa Darah Sewaktu (Stik), Hasil: 208mg/dL (< 200) Laboratorium Patologi Klinik (14-10-2026 19:42:49) - Hemoglobin, Hasil: 11.6g/dL (11.7 - 15.5) - Glukosa Darah Sewaktu, Hasil: 310mg/dL (< 200), Catatan: Secara pra analitik sampel baik, hasil sudah dilakukan pengulangan. - SGOT, Hasil: 39U/L (< 35) - Ureum, Hasil: 57mg/dL (21 - 43) - Kreatinin, Hasil: 1.80mg/dL (0.6 - 1.1)
- **Fisik dan klinis**: Tekanan darah: 149/70mmHg, Suhu tubuh: 36.5C, Denyut nadi: Reguler/92 kali/menit, Nafas: 20 kali/menit, SpO2: 96%, Skor nyeri null : 0
- **Riwayat Diet**
  **(berdasarkan kebiasaan makan)**: DM
- **Riwayat Personal**: Diagnosis: - Vomitus Profuse ec dalam pelacakan - DM dengan Hiperglikemia - Riw. Hipertensi - Hiponatremia & Hipochlorida ringan
- **Diagnosis Gizi**: Pembatasan asupan zat gizi Karbohidrat sederhana dan Natrium bd gangguan fungsi endokrin dan Hipertensi dd DM dengan Hiperglikemia (GDS, Hasil: 208mg/dL) , Hipertensi (Tekanan darah: 149/70mmHg)
- **Intervensi Gizi**: DIIT DIABETES MELLITUS RENDAH GARAM Tujuan Diet : Memberikan asupan gizi sesuai dengan kondisi dan penyakit pasien Terapi diet Bentuk : Makanan Lunak (ML)/BB Jenis diet : DMRG Rute : Oral Kebutuhan E dan zat gizi : E : 1776,64 kkal P : 63,21 g L : 53,13 g KH : 251,24 g (55%) Edukasi : Asupan makan sesuai kebutuhan dan diet pasien (3J) Kolaborasi : Asupan makan, ketepatan diet dan daya terima makan pasien
- **Rencana Monitoring & Evaluasi**: Monev : dilakukan 3H sekali 1. Asupan makan (80-110%) 2. Biokimia (sesuai rujukan normal) 3. Fisik/klinis (sesuai rujukan normal)
- **Petugas Dietisien/Nutrisionis**: Nisrina Andika Naharani, A.Md.Gz

**Status Nutrisi Pasien**

- **Status Nutrisi**: Normal
- **Keterangan**: IMT : 24,65 kg/m2 Status Gizi : Normal
- **User Insert**: NISRINA ANDIKA NAHARANI A.Md.Gz
- **Tanggal Insert**: 15-10-2026 09:29
- **Status Verif**: Belum Verif
- **Status Konsul**: Tidak Konsul

## DIAGNOSA

**Diagnosa Utama**: R11 - Nausea and vomiting
Diagnosa: Vomitus Profuse ec dalam pelacakan

**Diagnosa Sekunder 1**: E11.0 - Non-insulin-dependent diabetes mellitus: With coma
Diagnosa: DM dengan Hiperglikemia

**Diagnosa Sekunder 2**: I10 - Essential (primary) hypertension
Diagnosa: Riw. Hipertensi

**Diagnosa Sekunder 3**: E87.1 - Hypo-osmolality and hyponatraemia
Diagnosa: Hiponatremia Hipochlorida ringan

**Catatan Khusus Dokter**:

## RESEP

IRJ-261014-84441 tgl 14-10-2026 22:48 oleh Raden Triyono Edhi Sulistiyanto **84441**

- ANTASIDA SYR (1, 3x10) sebelum makan
- METOCLOPRAMIDE INJ (4, 3x1) 06 14 22

- NACL 500 ML INF (2, 0x0)
- NOVOFINE 32G 4MM (1, 0x0)
- NOVORAPID FLEXPEN (1, 3x8) 3x8 ui
- OMEPRAZOLE 40 MG INJ (2, 2x1) 12
- REBAMIPIDE TAB (1, 3x1) sebelum makan
- SPUIT 3CC NIPRO (4, 0x0)
- SPUIT 5CC NIPRO (3, 0x0)

IRJ-261015-85720 tgl 15-10-2026 19:56 oleh Raden Triyono Edhi Sulistiyanto **85720**

- IV CATHETER NO 24 SURFLO (2, 0x0)
- NACL 500 ML INF (2, 0x0)
- SPUIT 3CC NIPRO (2, 0x0)
- SPUIT 5CC NIPRO (2, 0x0)

IRJ-261015-84521 tgl 15-10-2026 07:00 oleh dr. Raden Triyono Edhi Sulistiyanto Sp.PD.,FINASIM **84521**

- METOCLOPRAMIDE INJ (3, 0x0)
- OMEPRAZOLE 40 MG INJ (2, 0x0)
- REBAMIPIDE TAB (3, 0x0)
- SPUIT 3CC NIPRO (3, 0x0)
- SPUIT 5CC NIPRO (3, 0x0)

IRJ-261016-85831 tgl 16-10-2026 06:50 oleh dr. Raden Triyono Edhi Sulistiyanto Sp.PD.,FINASIM **85831**

- OMEPRAZOLE 40 MG INJ (3, 0x0)
- REBAMIPIDE TAB (3, 0x0) sebelum makan
- SPUIT 10CC NIPRO (3, 0x0)

**EDUKASI PASIEN**

15-10-2026 09 NISRINA ANDIKA NAHARANI, A.Md.Gz

Diet dan nutrisi

- **Penerima**: Keluarga
- **Metode Edukasi**: Lisan
- **Frekuensi**: Edukasi Pertama
- **Respon**: Menyatakan Paham
- **Keterangan**: MB DMRG

Konsultasi gizi

- **Penerima**: Keluarga
- **Metode Edukasi**: Lisan
- **Frekuensi**: Edukasi Pertama
- **Respon**: Menyatakan Paham
- **Keterangan**: - Edukasi gizi pasien sesuai dengan dietnya (3J) - Edukasi penyimpanan BM dari luar RS

pengelolaan makanan dari luar rumah sakit

- **Penerima**: Keluarga
- **Metode Edukasi**: Lisan
- **Frekuensi**: Edukasi Pertama
- **Respon**: Menyatakan Paham
- **Keterangan**: Makanan disimpan di tempat tertutup agar tidak terjadi kontaminasi silang

15-10-2026 15 Nurul Ernawati, S.Far., Apt.

Aturan dan cara pemakaian obat

- **Penerima**: Pasien
- **Metode Edukasi**: Lisan
- **Frekuensi**: Edukasi Pertama
- **Respon**: Menyatakan Paham
- **Keterangan**: Edukasi obat yang diberikan terkait nama waktu cara dan indikasi pemberian obat

(https://insti.stream:3000) AKAN ()